

21 - 03.2- Les Troubles Phobiques - Pr. LAFFINTI

(0:02 - 3:26)

Pour le diagnostic différentiel, il se fait premièrement avec ce qu'on peut appeler une anxiété sociale normale, notamment dans des situations de rencontre avec des personnes nouvelles ou des situations impressionnantes ou des situations nouvelles, notamment chez des personnes qui sont timides. C'est aussi des situations où le trac habituel dans des situations de performances inhabituelles à réaliser en public. Cette anxiété reste légère, sans retentissement majeur.

Elle n'est pas persistante, elle est peu gênante et tend à s'améliorer avec l'expérience et avec la répétition des expériences. Le diagnostic différentiel se fait aussi avec les autres troubles anxieux, avec le trouble panique ou la crainte. L'anxiété anticipatoire, elle est en rapport avec la crainte de voir survenir une nouvelle attaque de panique, mais pas liée directement avec une situation sociale.

Dans l'anxiété généralisée, comme on a vu, c'est des soucis qui sont de tout et de rien, donc des choses de la vie quotidienne et pas spécifiquement, ça peut concerner certaines situations, mais pas uniquement des situations sociales. Le diagnostic différentiel se fait aussi avec les autres phobies, dont l'agoraphobie qu'on va voir, c'est la crainte des espaces ou des transports en commun par peur de voir survenir une crise ou des symptômes embarrassants. Pour l'ésophobie spécifique, c'est des peurs en lien avec des objets ou certaines situations spécifiques, mais qui ne sont pas forcément en lien avec une situation d'interaction sociale.

Pour le trouble obsessionnel compulsif et apparenté, notamment dans les obsessions impulsives, ou ce qu'on appelle aussi phobie d'impulsion, où le sujet a l'idée obsédante, intrusive, de craindre de faire un acte ridicule en public, mais cette idée obsédante est présente en dehors de toute situation, même en dehors de la situation sociale. Dans l'obsession d'une dysmorphie corporelle, la crainte est liée à une partie du corps jugée non conforme ou déformée par le sujet. Dans le trouble dépressif, il peut y avoir un retrait social, mais qui s'intègre dans le cadre global du syndrome dépressif, avec tristesse, avec anhédonie et les symptômes dépressifs associés.

(3:28 - 5:37)

Le diagnostic différentiel se discute aussi avec certains troubles de personnalité, notamment des personnes psychotiques, comme l'oppression à l'étésquizoïde, ou qui sont caractérisés par un certain isolement, un certain désintérêt social, avec très peu d'interactions, mais généralement il y a aussi d'autres préoccupations par des thèmes bizarres, des thèmes ésotériques, on peut avoir aussi des idées délirantes qui font pencher le diagnostic différentiel. Le diagnostic avec la personnalité évitante est un diagnostic qui reste très difficile, parce que les deux troubles sont généralement comorbides, et on peut considérer que le trouble de personnalité évitante est un désintérêt plus important et plus grave de l'anxiété sociale, parce que c'est tout un mode de

fonctionnement qui a envahi tout le champ de la vie du sujet, et c'est généralement ces personnalités évitantes qui vont rationaliser leur comportement et vont rejeter leur comportement sur les autres, donc il y a une certaine inconscience des troubles qui n'est pas présente dans l'anxiété sociale où le sujet reconnaît le caractère excessif de sa peur. Sur le plan étiopathogénique, le modèle de l'épigénèse avec cette double influence, avec une prédisposition héréditaire qui est influencée par des événements ou les influences environnementales est privilégiée, donc il y a des facteurs génétiques qui sont démontrés par certaines agrégations de cas de phobie sociale dans certaines familles, mais qui restent faibles.

(5:37 - 7:05)

Sur le plan neurobiologique, on avance le rôle des neuromédiateurs, notamment du système de sérotonine énergique, cette hypothèse est étayée par l'effet thérapeutique des inhibiteurs de la capture de la sérotonine, mais il y a aussi l'implication de certaines structures cérébrales dans le cas de phobie sociale qui sont démontrées par l'imagerie fonctionnelle. Les facteurs psychologiques sont représentés par la préexistence de certains tempéraments anxieux qui sont caractérisés par une émotivité, par l'inhibition de la petite enfance, mais aussi par certains traits de personnalité qui sont la faiblesse de soi, le manque de confiance et aussi le perfectionnisme. Certains facteurs éducatifs et de vie sont aussi des facteurs qui sont favorisant la survenue de troubles d'anxiété sociale, notamment une histoire de maltraitance ou de dénigrement répété pendant l'enfance, c'est aussi quand il y a une surprotection avec des messages de mise en garde répété vis-à-vis du monde extérieur par les parents.

(7:06 - 7:57)

Il y a aussi ce qu'on appelle le modèle de peur chez un parent, donc il y a une sorte d'apprentissage social de cette anxiété sociale. Parmi aussi les facteurs psychologiques, il y a le modèle cognitif comme celui de Clark qui suggère qu'il y a une certaine perception de soi comme étant un objet social qui va focaliser l'intention d'autrui et donc le sujet va entrer sur soi au détriment des interactions sociales. Certains facteurs comportementaux sont représentés par les évitements.

(7:58 - 8:37)

Les évitements des situations redoutées vont participer au maintien du trouble. En évitant la situation redoutée, le sujet a l'impression d'avoir évité un danger réel et ça permet de favoriser et de pérenniser le comportement d'évitement et le trouble de l'anxiété sociale. Sur le plan évolutif, son traitement, l'évolution de l'anxiété sociale est chronique et persistante.

(8:38 - 9:15)

Certaines atténuations ou quelques rémunérations spontanées peuvent se voir après de longues années d'évolution. L'évolution va dépendre bien sûr d'un traitement bien conduit qui donne

généralement des résultats assez importants. L'évolution de l'anxiété sociale peut aussi être marquée par des complications, notamment des complications dépressives qui peuvent se voir dans plus de 50-60% des cas.

(9:16 - 9:55)

C'est aussi des complications liées à l'automédication et l'usage abusif de certaines substances psychoactives comme l'alcool, comme les tranquillisants. L'anxiété sociale est aussi pourvoyeuse d'un handicap social très important, notamment en limitant les possibilités d'étudier sur le plan de la scolarité, de ses possibilités d'emploi et d'évolution dans sa carrière. C'est un trouble assez handicapant et assez invalidant.

(9:58 - 10:46)

Nous arrivons au chapitre de la prise en charge de l'anxiété sociale, dont le traitement se base sur deux volets complémentaires, un premier volet représenté par des psychothérapies cognitives et comportementales, et le deuxième volet fait appel au traitement médicamenteux, essentiellement les antidépresseurs. Les thérapies cognitives et comportementales sont des psychothérapies qui sont codifiées, qui sont réalisées par un thérapeute formé à cet effet. Elles donnent des résultats très significatifs en termes d'anxiété sociale.

(10:46 - 11:22)

Il s'agit d'une approche collaborative qui fait intervenir le thérapeute et aussi le patient, qui réalise cette forme de séance répétée en individuel ou de préférence en groupe. Le fait que ce soit en groupe donne l'avantage de mettre le patient devant des situations réelles avec d'autres personnes, des situations d'interaction sociale. Cela permet aussi d'apporter des bénéfices supplémentaires.

(11:23 - 12:17)

Plusieurs techniques sont utilisées dans ces thérapies. Premièrement, la technique d'entraînement aux habiletés sociales, ou les techniques d'affirmation de soi, qui vise à améliorer les difficultés communicationnelles et développer un savoir-faire relationnel à travers des conseils, à travers des techniques de jeu de rôle, etc. Il y a aussi la technique de l'exposition in vivo, qui va viser ou corriger les comportements d'évitement à travers une confrontation qui est graduée, mais prolongée, aux situations et aux stimuli anxiogènes.

(12:17 - 12:53)

Cela va entraîner, bien sûr, une habitude progressive et une désensibilisation. Les techniques de restructuration cognitive sont des techniques qui visent à identifier et à reconnaître les schémas de pensée qui sont dysfonctionnels, afin de permettre de les assouplir et de les modifier. Le traitement médicamenteux fait appel, en première intention, aux antidépresseurs qui

représentent le traitement de fond.

(12:55 - 13:31)

C'est surtout les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, mais aussi les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et la noradrénaline, qui ont montré leur efficacité en termes de phobie sociale. C'est un traitement qui est réservé normalement aux formes assez sévères, avec un handicap significatif, de préférence en association avec les TCC, avec les thérapies cognitives et comportementales. C'est un traitement complémentaire entre psychothérapie et pharmacothérapie.

(13:32 - 14:27)

À défaut de thérapies cognitives et comportementales, le traitement médicamenteux par antidépresseur est prescrit, dans la plupart des cas, dans la réalité de la pratique quotidienne. Parce que les TCC, c'est des techniques qui ne sont pas disponibles pour tout le monde, donc tout le monde ne peut pas avoir accès facilement à ces techniques parce qu'il y a un manque en termes de thérapeutes et aussi en termes de coûts, parce que c'est des séances assez chères et qui ne sont pas énormément remboursées. Ce traitement médicamenteux par antidépresseur devient indispensable en cas de dépression associée.

(14:27 - 14:47)

C'est une comorbidité très fréquente, comme on vient de le voir. À ce moment-là, le traitement antidépresseur devient indispensable. Les exemples de molécules antidépresseurs sont les mêmes qu'on a vus précédemment dans les cours précédents.

(14:48 - 15:10)

Toujours les mêmes principes, commencés par des doses progressives. Généralement, ça peut nécessiter le double de la posologie habituelle, donc deux comprimés et parfois trois comprimés pour certaines molécules. Le délai d'action de ce traitement est assez prolongé, entre 6 et 8 semaines.

(15:11 - 15:46)

La durée de traitement va aller de 6 à 12 mois après une réponse satisfaisante. Bien sûr, pour l'arrêt, elle se fait de façon progressive. Pour les autres médicaments, essentiellement les benzodiazépines et les anxiolytiques, ils n'ont pas d'effet propre sur la phobie sociale elle-même, mais plutôt ce sont des traitements qui sont utilisés de façon ponctuelle pour traiter une anxiété aiguë assez importante.

(15:47 - 16:23)

Mais ce traitement doit être limité dans le temps parce qu'il y a un risque d'automédication et risque de développer une dépendance à ces molécules. D'autres classes thérapeutiques représentées par les bêtas-bloquants. Les bêtas-bloquants sont intéressants dans les formes d'anxiété sociale qui est limitée généralement à des situations ou des catégories de situations de performance avec des symptômes cardiovasculaires et neurologiques au premier plan.

(16:23 - 16:43)

Le traitement se fait de façon ponctuelle. On peut prendre un demi-à-un comprimé 45 minutes ou une heure avant la confrontation avec la situation de performance. Donc type avleucardie, un demi-à-un comprimé avant la confrontation.

(16:44 - 17:36)

C'est un traitement ponctuel et il ne doit pas être pris de façon continue. Après l'anxiété sociale, nous allons passer au deuxième trouble phobique qui est l'agoraphobie. Pour définir l'agoraphobie, il s'agit d'un trouble anxieux qui est caractérisé par une peur ou une anxiété intense qui est durable et qui est en rapport avec le fait de se retrouver dans un endroit ou dans une situation où il pourrait être difficile de s'échapper ou de trouver des secours en cas de survenue d'une crise d'angoisse, d'une attaque de panique ou de survenue d'autres symptômes embarrassants ou incapacitants.

(17:37 - 18:12)

Ces situations sont alors évitées ou sont subies avec une souffrance intense où il nécessite la présence de quelqu'un ou d'un accompagnant. Les situations dites agoraphobogènes à l'origine de cette peur ou de cette anxiété intense sont diverses. Cela peut être des transports en commun, des voitures, des bus, des trains, etc.

(18:12 - 18:58)

Cela peut aussi être des endroits ouverts comme des parkings, des marchés, des ponts ou à l'inverse des endroits clos comme les magasins, les salles de cinéma, les théâtres ou une mosquée par exemple. Cela peut être le fait de se retrouver aussi dans une file d'attente ou dans une foule ou tout simplement la simple présence à l'extérieur du domicile en étant seul peut être une situation agoraphobogène. Sur le plan épidémiologique, l'agoraphobie, la prévalence annuelle est de 1,7%.

(18:58 - 19:20)

Il y a une prédominance féminine comme pour l'anxiété sociale, donc de femmes pour un homme. L'incidence maximale se voit à la fin de l'adolescence et en début de l'âge adulte. Cette agoraphobie est souvent comorbide à d'autres troubles anxieux, notamment le trouble panique.

(19:22 - 19:50)

Certains facteurs de risque sont représentés par des facteurs génétiques qui sont plus importants dans l'agoraphobie par rapport à l'anxiété sociale. Le facteur génétique dans l'agoraphobie est plus important. Concernant les facteurs de risque environnementaux, ils sont représentés par des événements négatifs durant l'enfance.

(19:50 - 20:11)

Notamment une surprotection ou une ambiance familiale qui est perturbée. Mais c'est aussi le fait d'être agressé ou attaqué dans un endroit. Ça peut être le facteur de risque déclenchant d'une agoraphobie.

(20:17 - 20:46)

Le diagnostic positif de l'agoraphobie est également clinique. Pour résumer les critères diagnostiques, le diagnostic repose sur l'existence d'une peur exagérée de ne pouvoir s'échapper ou d'être secouru. Pour deux ou plus des situations qu'on vient de voir dans les cinq catégories de situation agoraphobogène.

(20:48 - 21:11)

Cette peur va être à l'origine de comportements d'évitement ou de réassurance, c'est-à-dire le fait d'être accompagné par quelqu'un. Elle sera aussi à l'origine d'une détresse et d'une altération significative du fonctionnement du sujet. Il y a aussi le critère de durée de plus de six mois.

(21:12 - 21:46)

Il faut que cette peur, ces évitements soient présents au-delà de six mois ou au minimum six mois pour retenir le diagnostic d'agoraphobie. Et bien sûr, il faut que cette agoraphobie ne soit pas liée ou expliquée par une autre pathologie somatique, mentale ou l'effet d'une substance psychoactive. Le diagnostic différentiel de l'agoraphobie se fait essentiellement avec les autres phobies.

(21:49 - 22:42)

Notamment la phobie spécifique de type situationnel qui est en rapport avec certaines situations particulières qu'on va voir un peu plus tard. Il se fait également avec la phobie sociale, donc on vient de la voir, qui concerne les situations d'interaction sociale. Le diagnostic différentiel se fait aussi avec le trouble panique qui est caractérisé par la répétition ou la récurrence des attaques de panique avec une anxiété anticipatoire en rapport avec de nouvelles attaques ou par rapport à leur implication qui est supérieure à un mois, mais qui peut évoluer s'il y a des évitements des endroits qu'on vient de citer et qui peut évoluer vers une agoraphobie.

(22:48 - 23:35)

Dans le trouble stress post-traumatique, il peut y avoir un comportement d'évitement de certains endroits, mais qui sont en lien avec un événement traumatisant. Donc les endroits qui rappellent le traumatisme initial peuvent être évités par le patient traumatisé psychique, mais cet événement reste lié à ces endroits en lien avec un rappel du traumatisme. Dans le trouble dépressif, le retrait et l'événement peuvent s'intégrer, peuvent être présents, mais qui s'intègrent dans un cadre d'un tableau dépressif caractérisé avec tristesse, avec pessimisme, anhédonie, etc.

(23:41 - 24:28)

L'évolution de l'agoraphobie se fait généralement de façon chronique et persistante. Les rémissions à long terme peuvent se voir, mais dépendent de l'instauration d'un traitement bien conduit. Les rechutes sont très fréquentes et les complications évolutives peuvent être représentées par l'installation d'une dépression, par le recours à l'usage abusif de substances écoactives et pour certaines formes sévères de l'agoraphobie où le patient va éviter de se rendre à plusieurs endroits ou seulement être à l'extérieur de son domicile.

(24:28 - 24:54)

Cela va conduire à un repli à domicile avec une certaine dépendance vis-à-vis de l'entourage familial. La prise en charge de l'agoraphobie fait appel aux traitements psychothérapeutiques et pharmacothérapeutiques. Les TCC sont à privilégier en première intention dans l'agoraphobie.

(24:55 - 25:22)

Le résultat est intéressant, ils sont prolongés. Les techniques utilisées sont surtout l'exposition graduée in vivo. On va essayer d'exposer progressivement le sujet aux situations agoraphobogènes, en commençant par les situations qui donnent moins d'anxiété et en augmentant progressivement.

(25:23 - 25:57)

Cela peut aussi être une exposition en imagination en présence d'un thérapeute. Pour les formes très sévères où l'exposition in vivo peut être déconseillée au début, on peut commencer par une exposition en imagination en présence d'un thérapeute. Il y a aussi certaines techniques d'exposition par réalité virtuelle, en utilisant des moyens technologiques actuels pour faire des expositions virtuelles.

(26:00 - 26:46)

Le traitement médicamenteux se base sur les antidépresseurs, qui représentent aussi un traitement de fonds pour l'agoraphobie. Notamment s'il y a un antécédent ou s'il y a un trouble panique comorbide, ils deviennent indispensables. Ce sont essentiellement les IRS, les

inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, pour une durée de 6 à 12 mois, et bien sûr en respectant les recommandations du traitement antidépresseur en termes d'instauration, de surveillance et d'arrêt progressif.

(26:47 - 27:40)

Les anxiolytiques, quant à eux, leur place est limitée et réservée à une anxiété aiguë, et comme on a dit, ils doivent être prescrits avec parcimonie et pendant une durée très limitée, pour éviter les risques de sevrage et de dépression. Nous continuons avec le troisième trouble phobique, qui sont les phobies spécifiques, anciennement appelées phobies simples. Ces phobies spécifiques sont définies par l'existence d'une peur intense qui est disproportionnée, et qui est déclenchée par la présence de certains animaux, ou certains objets, ou des situations particulières, qui sont appelées objets au stimulus phobogène.

(27:41 - 27:54)

Cette peur va conduire le patient à éviter systématiquement l'objet de ses craintes. Leur prévalence est de 11%. Ils sont généralement de diagnostics faciles.

(27:54 - 28:43)

Ils sont à l'origine d'une faible demande de soins, du fait d'un authenticisme socioprofessionnel qui est faible, qui est modéré, et généralement, c'est un trouble dans le traitement de bons résultats. Ce sont des phobies qui débutent généralement à l'enfance, entre 7 et 11 ans, avec un âge moyen de 10 ans, qui vont persister à l'âge adulte chez la majorité des sujets. Ces phobies sont à distinguer des peurs excessives qui appartiennent généralement au processus normal de maturation au cours de l'enfance, et qui vont disparaître à l'adolescence.

(28:45 - 29:26)

Il s'agit généralement d'une peur isolée d'une seule situation ou d'un seul objet, mais souvent, il y a une peur qui concerne plus d'un objet, dans la plupart des cas. Le sujet, bien sûr, est conscient du caractère morbide de sa peur, du caractère excessif. L'exposition à l'objet ou à la situation phobogène déclenche toujours une anxiété, à l'origine d'un comportement d'évitement ou d'échappement de la situation ou de l'objet phobogène.

(29:29 - 30:05)

Il y a différentes catégories de phobies spécifiques, notamment les phobies des animaux, les plus communes, les plus fréquentes, notamment chez les femmes. Cette peur est en lien généralement soit avec l'apparence de l'animal ou par rapport à ses mouvements rapides, etc. Les plus connues sont celles des phobies des insectes, comme la peur des araignées, la arachnophobie, la peur des souris, aussi la peur des serpents, des chats.

(30:08 - 30:54)

Deuxième catégorie concerne les éléments naturels, où les principaux éléments à l'origine d'une peur sont les orages, le tonnerre, mais aussi l'éroteur, l'acrophobie, l'eau, l'obscurité et d'autres éléments naturels qui peuvent être l'objet de la peur. Troisièmement, les phobies liées au sang, à la vue du sang, ou la peur des injections, ou la peur des blessures ou des interventions chirurgicales. La peur des chirurgiens dentistes ou des soins dentaires sont rattachées à cette catégorie de phobies liées au sang.

(30:58 - 31:32)

Ces phobies liées au sang ont la particularité d'être accompagnées par une certaine bradycardie et peuvent conduire à une syncope. Cette phobie des sangs, des injections, des soins et des interventions peut conduire le patient à complètement négliger son état de santé par peur des interventions ou des injections ou des soins. Quatrième catégorie, c'est les phobies de type situationnel.

(31:32 - 32:05)

C'est intéressant de signaler ici cette phobie de type situationnel où la peur est en rapport avec une situation particulière comme le fait de prendre l'avion, de prendre le train ou l'ascenseur. Ce n'est pas la même chose que dans le cadre de l'agoraphobie. Là, généralement, la phobie concerne une seule situation et l'objet de la peur, c'est la situation elle-même.

(32:06 - 32:38)

Ce n'est pas comme dans l'agoraphobie. Dans l'agoraphobie, dans le cadre des transports en commun, par exemple, la peur, c'est d'avoir un malaise ou d'avoir une attaque de panique ou d'avoir des symptômes qui sont invalidants quand le sujet va prendre ses transports en commun ou quand ce sujet va se retrouver dans un espace clos ou dans un espace ouvert. Ici, la phobie est en rapport avec la situation elle-même.

(32:38 - 33:05)

C'est la peur du train, la peur de l'ascenseur. Elle n'est pas en rapport avec la peur d'avoir une crise d'angoisse. La prise en charge des phobies spécifiques fait appel essentiellement aux thérapies cognitives et comportementales parce qu'il n'existe pas de médicament spécifique pour la phobie spécifique.

(33:05 - 33:38)

Les anxiolytiques benzodiazépiniques peuvent être utilisés s'il y a une angoisse importante et de façon actuelle. Les antidépresseurs, quant à eux, sont indiqués en cas de comorbidité qui nécessite un traitement antidépresseur, notamment une dépression ou un trouble anxieux

caractérisé autre que la phobie spécifique. Pour les thérapies cognitives et comportementales, ils donnent des résultats assez importants et assez satisfaisants.

(33:38 - 34:19)

La technique utilisée est la même pour les autres phobies. C'est une technique d'exposition graduée in vivo qui va permettre une confrontation progressive avec l'objet ou la situation phobogène qui va entraîner une habitude, une désensibilisation avec l'acquisition d'une réponse plus adaptée devant ces situations. Le fait de se confronter de plus en plus va atténuer l'anxiété.

(34:20 - 34:40)

Avec la répétition des expositions, la phobie tend à décroître et à disparaître. En résumé, les troubles phobiques sont très fréquents. Certains sont à l'origine d'une gêne et d'un handicap assez important.

(34:41 - 35:00)

Le rôle du médecin généraliste reste primordial dans la reconnaissance des troubles mais aussi dans l'information délivrée aux patients. Cela va permettre d'instaurer des traitements précoces et prévenir les complications. Je vous remercie.